

SHOCK ANAFILÁCTICO

L.J. Valdivia Ruiz, A.M. Fernández Martínez, J.P. Núñez Casco.

INTRODUCCIÓN

La anafilaxia es una reacción alérgica grave de instauración rápida y potencialmente mortal. Se trata de un síndrome complejo, desencadenado por mecanismos inmunitarios o no, con aparición de síntomas y signos sugestivos de una liberación generalizada de mediadores de mastocitos y basófilos, tanto en la piel como en otros órganos. La incidencia estimada es de 50 a 112 episodios por 100.000 personas-año. Por grupos de edad, en los niños de 0 a 4 años es tres veces mayor que en el resto de los grupos.

La incidencia de shock anafiláctico varía entre 3,2 y 10 por 100.000 personas-año, con una mortalidad que llega hasta el 6,5%.

Las causas más frecuentes de anafilaxia son: alimentos (sobre todo en la infancia), fármacos (en adultos) y picaduras de himenópteros. Entre los alimentos destacar los frutos secos, marisco y pescado, además de la fruta en adultos y los huevos y la leche en niños; y de los fármacos los AINEs, antibióticos (sobre todo betalactámicos) y los contrastes radiológicos. En el medio hospitalario, no olvidarse del látex.

DIAGNÓSTICO

- **Sospecha clínica:** debe sospecharse cuando aparece de manera aguda (minutos o pocas horas) un síndrome rápidamente progresivo que afecta a la piel (urticaria, prurito, eritema, flushing) y/o mucosas (edema de labios, úvula o lengua), y que se acompaña de compromiso respiratorio (disnea, sibilancias, estridor, hipoxemia) o circulatorio (descenso de TA o síntomas asociados de disfunción orgánica). Recordar que hasta en un 20% las anafilaxias cursan sin afectación cutánea.
- **Evaluación de la gravedad:** la gravedad se relaciona con la rapidez en la progresión de los síntomas, con el tipo de antígeno y su vía de entrada, y con los órganos afectados. Así las **anafilaxias graves:** definidas por la presencia de cianosis, una saturación de O₂ $\leq 92\%$ ($\leq 95\%$ en los niños), hipotensión, confusión, hipotonía, pérdida de consciencia o incontinencia. **Anafilaxias moderadas:** presentan signos o síntomas que sugieren afectación respiratoria, cardiovascular o gastrointestinal: disnea, estridor, sibilancias, náuseas, vómitos, mareo, sudoración, opresión torácica, dolor abdominal o sensación de garganta ocupada.
- **Pruebas de laboratorio:** hemograma, bioquímica, coagulación si toma de anticoagulantes, también se debe de realizar determinación de las concentraciones plasmáticas de **histamina** (no se utiliza en la práctica clínica por su rápido metabolismo en 60 minutos por las enzimas N-metiltransferasa y diaminoxidasa) y de **triptasa total** (no están establecidos los límites, pero se acepta una elevación de al menos dos veces el valor basal), es la prueba mas útil para el diagnóstico de la anafilaxia, se debe solicitar en forma seriada: La primera tras inicio del tratamiento, la segunda dos horas después de iniciado el cuadro, la tercera a partir de las 24 horas (retornan los valores normales entre 6 y 9 horas tras la crisis).

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

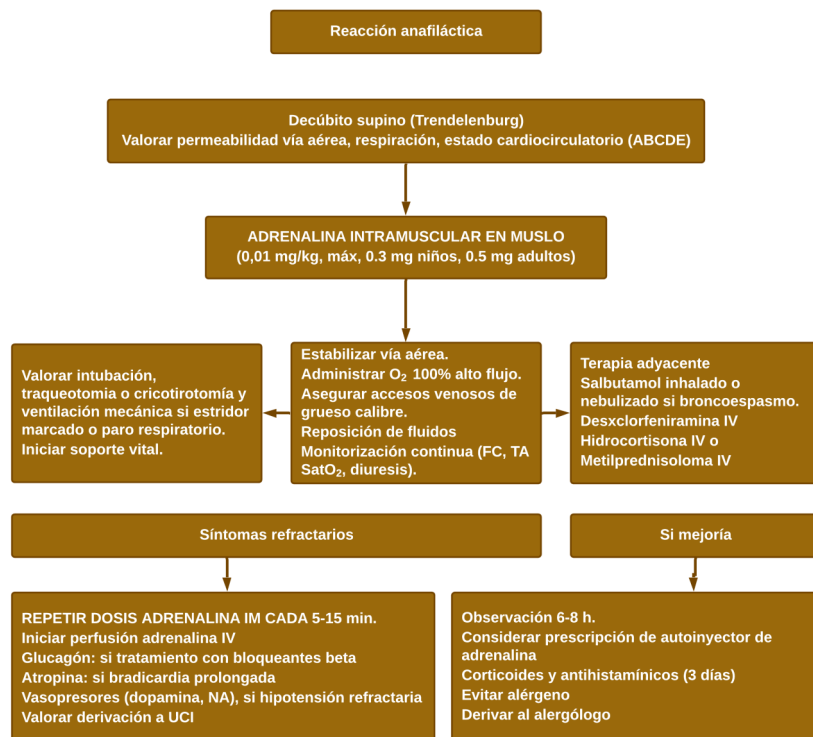
- Posición en decúbito supino con extremidades inferiores elevadas (Posición en Trendelenburg, excepto si esta disneico o está vomitando).
- Monitorización tan pronto como sea posible (pulsioximetría, medición de TA, FC, FR y

monitorización ECG).

- Retirada del alérgeno, de ser posible: suspender administración del fármaco, retirar aguijón tras la picadura de una abeja, o restos de alimentos presentes en la boca....
- Tratamiento inicial basado en la aproximación **ABCDE** (valorar permeabilidad vía aérea, respiración y estado cardiocirculatorio).
- Administrar **O2 al 100%**.
- Asegurar accesos venosos. Adultos: nº 14 G - 16 G.
- **Reposición de fluidos.** Si hipotensión SSFF o Ringer Lactato. **Adultos:** suero fisiológico 0,9% 1-2 l/h/I.V. **Niños:** suero fisiológico 0,9% 20 ml/kg/I.V. cada 5 -10 min.
- **Adrenalina I.M.** Lo más precoz posible I.M. Si inestabilidad hemodinámica administrar IV. Es el medicamento de elección en el tratamiento de la anafilaxia.
 - **Dosis Adultos:** vía IM. 0,3-0,5 mg (0,3-0,5 ml) por vía IM o subcutánea, la vía IM es la más rápida y efectiva (cara anterolateral del muslo). En caso de shock anafiláctico debe utilizarse la vía IM o en casos muy graves y a nivel hospitalario la vía IV. Se puede repetir la administración a los 15-20 minutos si precisa y posteriormente, a intervalos de 4 horas. En situaciones graves se puede aumentar la dosis hasta 1 mg (1 ml).
 - **Dosis Niños:** vía IM. 0,01 mg (0,01 ml) por kg de peso corporal por vía IM o subcutánea hasta una dosis máxima de 0,5 mg (0,5 ml). Se puede repetir a los 15-20 minutos y, posteriormente, a intervalos de 4 horas. Si estridor laríngeo se puede administrar adrenalina nebulizada (1-2 ml) tras la administración de adrenalina IM. Valorar necesidad de infusión de adrenalina intra venosa (I.V.) si persisten los síntomas o si los síntomas son graves.
 - **Perfusión IV de adrenalina: Adultos:** diluir 1 mg en 100 ml de suero fisiológico 0,9%= 0,01 mg/ml. Dosis 0,5 - 1 ml/kg/h, dosis máx. 6 ml/kg/h. **Niños:** diluir 1 mg en 100 ml de suero fisiológico 0,9%= 10 mcg/ml. Dosis 0,1 -1 mcg/kg/minuto.
- **Terapia adyuvante:**
 - **Dexclorfeniramina I.V.** Adultos. Polaramine 5 mg/6-8 horas IV lento o IM. Niños: 0,15-0,3 mg/kg/dosis (máximo 5 mg/dosis) IV lento o IM.
 - **Hidrocortisona I.V.** (Actocortina 500 mg/6-8h ó 100 mg/2-6h).
 - **Salbutamol nebulizado.** Si broncoespasmo. 2,5-5 mg diluidos en 2-5 ml de SSF cada 10-20 minutos. Niños: 0,02-0,03 ml/kg (0,10-0,15 mg/kg).
- **Glucagón.** Indicado en pacientes que reciben tratamiento con betabloqueantes. **Adultos.** 1-2 mg IV/IM en bolo, seguido de infusión 0,05 - 0,1 mg/kg/hora. **Niños.** 20 - 30 mcg/kg en bolo, seguido de infusión 5-15 mcg/minuto.
- **Atropina I.V.** Si bradicardia prolongada. **Adultos:** 0,5-1 mg en bolo, máximo 3mg. **Niños:** 0,02 mg/kg en bolo.
- **Vasopresores** (Dopamina, Noradrenalina) si hipotensión refractaria.
 - **Dopamina.** Diluir 2 ampollas (200 mg) en 500 ml SG 5% = 800 mcg/ml (60 mcg/min = 4,5 ml/hora). 1 a 4 mcg/kg/minuto efecto dopaminérgico. 5 a 7 mcg/kg/ minuto efecto beta-1. > 8 a 10 mcg/kg/ minuto efecto alfa-1.
 - **Noradrenalins. Adultos.** Diluir 2 ampollas (10 mg) en 100 ml suero glucosado al 5%. Dosis. Iniciar con 5 ml/hora y subir de 5 en 5 ml/hora según respuesta de la tensión arterial. **Niños.** Diluir 1 mg en 100 ml de suero glucosado al 5% = 10 mcg/ml. Dosis.0,05-1 mcg/kg/minuto.
- Valorar intubación orotraqueal. Si persiste estridor,broncoespasmo o signos de paro cardiorespiratorio inminente.
- Valorar interconsulta/derivación a UCI.
- Todo paciente que haya sufrido una anafilaxia debe ser remitido, con carácter preferente, al

alergólogo para estudio.

- ANTE POSIBILIDAD DE SHOCK ANAFILÁCTICO INICIAR TRATAMIENTO BASADO EN EL ABCDE Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO (Adrenalina + Dexclorfeniramina + Hidrocortisona).



BIBLIOGRAFÍA

- Cardona V, Cabañes N, Chivato T, De la Hoz B, Fernández Rivas M, Gangoiti Goikoetxea I, Guardia P, Herranz Sanz M.A, Juliá Benito J.C, Lobera Labairu T, Praena Crespo M, Prieto Romo J.I, Sánchez Salguero C, Sánchez J. I, Uixera Marzal S, Vega A, Villarroel P. Guía de actuación en Anafilaxia: GALAXIA 2016. Editorial ESMON PUBLICIDAD, S.A.
- Irwin and Rippe's Intensive Care Medicine. Seventh edition.